

Un parent autiste dans votre équipe de soins / maternité

Pour les sages-femmes, les visiteuses de santé, le personnel de maternité et les infirmiers communautaires — soutenir un adulte autiste qui est (ou devient) parent.

L'idée principale

L'autisme, à travers le **monotropisme**, signifie que l'attention d'un parent se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. La grossesse, l'accouchement et les débuts de la parentalité sont implacables, multi-canaux et imprévisibles — précisément les conditions que le système monotropique a le plus de mal à gérer — les parents autistes courent donc un **risque élevé de burnout** et ignorent souvent leurs propres besoins. Les environnements de maternité et de soins communautaires peuvent être hostiles sur le plan sensoriel et riches en surprises. Des soins prévisibles, calmes, littéraux et une vérification proactive protègent à la fois le parent et le bébé.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous pouvez observer...	Ce qui se passe souvent
Surchargé sensoriellement, anxieux ou en shutdown en clinique/travail	Un environnement multi-canaux sur un système monotropique — et non une « incapacité à faire face »
Manque des rendez-vous, ignore sa propre douleur ou ses symptômes	Différences d' intéroception + hyper-focalisation sur le bébé
Routines rigides autour de l'alimentation et du coucher	La prévisibilité réduit la charge — ce n'est pas du « contrôle »
Diagnostiqué seulement après son enfant	Un parcours courant vers l'identification à l'âge adulte
Devient silencieux ou non-verbal sous pression	Shutdown — besoin de calme, pas de pression pour « s'engager »

Essayez ceci

- **Proposez l'AHAT d'AASPIRE** et des options de **contact privilégiant l'écrit** ; autorisez la présence d'un partenaire ou d'un accompagnateur.
- **Rendez les soins périnataux prévisibles** : même clinicien, salle calme, plan écrit clair ; expliquez chaque étape avant de l'effectuer.
- **Interrogez-les proactivement sur la douleur, l'épuisement et l'alimentation** — ils ont tendance à sous-déclarer.
- **Réduisez la charge sensorielle** en clinique et dans le service (lumière tamisée, moins de bips, moins de surprises).
- **Dépistez le burnout autistique et les troubles mentaux périnataux** — les deux se chevauchent et nécessitent des soins spécifiques.

Évitez ceci

- Interpréter une surcharge ou un shutdown comme un « manque de lien » avec le bébé, ou comme une simple dépression.
- Visites à domicile surprises sans préavis, ou procédures imprévisibles.
- Supposer qu'ils demanderont d'aide d'eux-mêmes lorsqu'ils seront en difficulté — ce n'est souvent pas le cas.

Quand chercher plus de soutien

Surveillez le **burnout autistique** et les troubles mentaux périnataux ; traitez les troubles co-occurents du **TDAH, l'anxiété, le sommeil et les troubles gastro-intestinaux**. Orientez-les vers un **soutien entre pairs de parents autistes** et une aide pratique. Lorsque le foyer comprend un enfant neurodivergent, coordonnez-vous avec les services pédiatriques.

Si le parent est une mère

Les mères autistes sont fréquemment mal diagnostiquées (anxiété/dépression périnatale) et pratiquent un masking intense, y compris avec les cliniciens. Interrogez-les sur les différences sociales/sensorielles présentes depuis l'enfance, et pas seulement sur l'humeur actuelle.

À propos de ce guide

*Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour la famille** (Partie 4), le **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.4 & 4) et la brève sur le **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic**. À adapter à l'individu.*

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT. Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.